

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL
DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**ACTITUD Y CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA EN PUÉRPERAS, HOSPITAL
II-1 RIOJA, SAN MARTÍN- 2024.**

Autora : Bach. Raquel Vasquez Regalado

Asesor : Dr. Edwin Gonzales Paco

Registro (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

Dedicatoria

A Dios, por ser mi fortaleza en cada momento.

A mi madre, cuyo afecto sin condiciones y entrega han sido la base de mis éxitos; te agradezco por tu respaldo constante y por enseñarme el valor de la perseverancia y la dedicación.

A mis seres queridos, por acompañarme en todo momento, quienes me han ofrecido su amor, aliento y motivación, siendo en mi vida un regalo invaluable.

Agradecimiento

A todas las puérperas por haberme permitido recabar la información para hacer realidad el informe de tesis.

Al Dr. Ciro Alejandro Sihuas Andrade director del Hospital II-1 Rioja por permitir acceder a los datos.

A la Lic. Enf. Kelly Gómez Tuesta, por su apoyo y predisposición de los trámites administrativos para recabar la información.

Al Dr. Edwin Gonzales Paco, por su invaluable orientación, paciencia y por compartir su experiencia. Su apoyo incondicional y sus consejos me han permitido llevar a cabo esta investigación con éxito.

A todos aquellos que, de alguna manera, han aportado a la ejecución de la presente investigación.

**Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas**

Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana.

Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres

Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza

Vicerrectora de Investigación

Dr. Yshoner Antonio Silva Diaz

Decano de la Facultad Ciencias de la Salud

Visto Bueno del Asesor de la Tesis



ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada Actitud y Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en Puerperas, Hospital II-d Rioja, San Martín - 2024; del egresado Bach. Raguél Vázquez Regalado de la Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela Profesional de Enfermería. de esta Casa Superior de Estudios.

El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

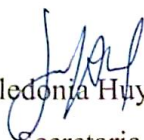
Chachapoyas, 30 de Junio de 2025


Firma y nombre completo del Asesor
Dr. Edwin González Paco
DNI. 19990654
Docente DEn Px

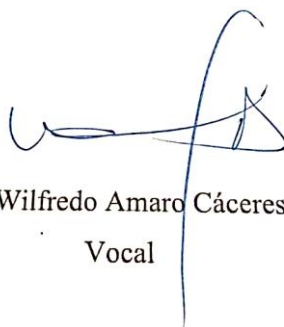
Jurado Evaluador de la Tesis
Resolución de Decanato N°592-2024-UNTRM-VRAC/FACISA



Dra. Sonia Tejada Muñoz
Presidente

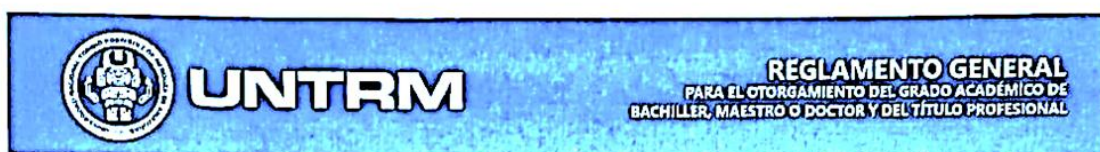


Ms Sonia Celedonia Huynhua Gutierrez
Secretaria



Dr Wilfredo Amaro Cáceres
Vocal

Constancia de Originalidad de la Tesis



ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas,
Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024

presentada por el estudiante ()/egresado (X) Raquel Vasquez Regalado

de la Escuela Profesional de Enfermería

con correo electrónico institucional 7594171291@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

- La citada Tesis tiene 23 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor (X) / igual () al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 14 de Noviembre del 2025


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

.....
.....

Reporte Turnitin

TNT 21 - ACTITUD Y CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA EN PUÉRPERAS, HOSPITAL II-1 RIOJA,
SAN MARTÍN- 2024.

INFORME DE ORIGINALIDAD

23%

INDICE DE SIMILITUD

22%

FUENTES DE INTERNET

8%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

10%

2

core.ac.uk

Fuente de Internet

1%

3

repositorio.untrm.edu.pe

Fuente de Internet

1%

4

Submitted to Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga

Trabajo del estudiante

1%

5

repositorio.ucss.edu.pe

Fuente de Internet

1%

6

repositorio.udch.edu.pe:4000

Fuente de Internet

1%

7

repositorio.uwiener.edu.pe

Fuente de Internet

1%

8

Submitted to Universidad Nacional Toribio
Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Trabajo del estudiante

<1%

9

Submitted to Universidad Catolica Sedes
Sapientiae

Trabajo del estudiante

<1%

10

Submitted to Universidad Andina Nestor
Caceres Velasquez

Trabajo del estudiante

<1%

Acta de Sustentación de la Tesis



ANEXO 3-5

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 01 de Diciembre del año 2023, siendo las 17:40 horas, el aspirante: VASQUEZ REGALADO RAQUEL, asesorado por Dr. Edwin Gonzales Paco defiende en sesión pública presencial (☒) / a distancia (☐) la Tesis titulada: Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en púerperas. Hospital II-1 Rioja, San Martín-2024, para obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Dra. Sonia Tejada Muñoz

Secretario: Ms. Sonia Celedonia Huyhua Gutierrez

Vocal: Dr. Wilfredo Amaro Cáceres



Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) / Mayoría (☐)

Desaprobado (☐)

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 18:33 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.

[Firma]
SECRETARIO

[Firma]
VOCAL

[Firma]
PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas	iv
Visto Bueno del Asesor de la Tesis	v
Jurado Evaluador de la Tesis	vi
Constancia de Originalidad de la Tesis	vii
Reporte turnitin	viii
Acta de Sustentación de la Tesis	ix
Índice	x
Resumen	xii
Abstract	xiii
I. INTRODUCCIÓN	14
II. MATERIAL Y MÉTODOS	18
III. RESULTADOS	23
IV. DISCUSIÓN	26
V. CONCLUSIONES	30
VI. RECOMENDACIONES.....	31
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32
ANEXOS	35

Índice de Tablas

	Pág
Tabla 1: Puérperas atendidas en el Hospital II-1 Rioja desde el mes de Enero – Agosto del año 2024.....	19
Tabla 2: Relación que existe entre actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín – 2024.....	23
Tabla 3: Actitud sobre lactancia materna exclusiva según sus dimensiones en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín – 2024.....	24
Tabla 4: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva según sus dimensiones en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín – 2024.....	25
Tabla 5: Actitud sobre lactancia materna exclusiva según grado de instrucción en puérperas del Hospital II-1 Rioja, San Martín, 2024.....	57
Tabla 6: Actitud sobre lactancia materna exclusiva según grupo etario en puérperas del Hospital II-1 Rioja, San Martín, 2024.....	58
Tabla 7: Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva según etapas del puerperio, en puérperas del Hospital II- Rioja, San Martín, 2024.	59

Resumen

El propósito de la investigación fue determinar la relación entre la actitud y el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas del Hospital II-1 Rioja - 2024. La hipótesis alterna fue; existe una relación significativa entre la actitud y el conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas. Se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo, relacional, observacional, prospectivo, transversal; para lo cual se aplicó el método hipotético - deductivo; los datos se registraron con la técnica de la encuesta, y como instrumentos el cuestionario de actitudes y de conocimiento de lactancia materna con una validez (0.90 y 0.88) y confiabilidad por Alfa de Cronbach (0.79 y 0.87) respectivamente. La población muestral fue 95 puérperas. Resultados, el 35.8% presentaron una actitud favorable con un conocimiento alto sobre la lactancia materna exclusiva; 23.2%, actitud medianamente favorable con conocimiento medio, no se registraron actitudes desfavorables; en términos generales, el 58.9% de puérperas mostró una actitud favorable y el 49.5% alcanzó un nivel alto de conocimiento. En conclusión, se confirmó la hipótesis alterna ($p = 0.031$), evidenciando una relación significativa entre las variables de estudio.

Palabras Clave: Actitud, conocimiento, lactancia materna exclusiva, puérperas.

Abstract

The purpose of this research was to determine the relationship between attitude and knowledge about exclusive breastfeeding in postpartum women at Hospital II-1 Rioja in 2024. The alternative hypothesis was that a significant relationship exists between attitude and knowledge about exclusive breastfeeding in postpartum women. The study was conducted using a quantitative, relational, observational, prospective, and cross-sectional approach. The hypothetical-deductive method was applied, and data were collected using a survey. The instruments were a breastfeeding attitude questionnaire and a breastfeeding knowledge questionnaire, with validity (0.90 and 0.88) and reliability (Cronbach's alpha) (0.79 and 0.87), respectively. The sample consisted of 95 postpartum women. Results showed that 35.8% presented a favorable attitude with a high level of knowledge about exclusive breastfeeding; 23.2% had a moderately favorable attitude with a medium level of knowledge; no unfavorable attitudes were recorded. Overall, 58.9% of postpartum women showed a favorable attitude, and 49.5% achieved a high level of knowledge. In conclusion, the alternative hypothesis was confirmed ($p = 0.031$), demonstrating a significant relationship between the study variables.

Keywords: Attitude, knowledge, exclusive breastfeeding, puerperal women.

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la leche materna constituye el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo saludable de los recién nacidos, es un recurso natural seguro, libre de contaminantes y rico en anticuerpos que protegen al lactante contra diversas enfermedades durante la infancia, además proporciona la energía, vitaminas y nutrientes esenciales desde los primeros días de vida, y continúa siendo un componente fundamental de la alimentación en etapas posteriores, asimismo se recomienda iniciar la lactancia dentro de la primera hora tras el nacimiento y mantenerla de forma exclusiva durante los seis primeros meses, sin la incorporación de otros líquidos ni alimentos, ni siquiera agua; además, se sugiere alimentar al lactante a libre demanda, tanto de día como de noche (OMS, 2023).

Según Grajales (2021), el conocimiento es un proceso dinámico por el cual los individuos construyen significados a partir de la experiencia, la información y la interacción con su entorno, desarrollando habilidades para interpretar, actuar y transformar la realidad, desde este punto la lactancia materna es la comprensión que tienen las madres sobre los beneficios que tiene la leche materna.

Por su parte, la actitud es una disposición psicológica y afectiva, innata o adquirida, que guía la forma en que una persona siente y actúa frente a un objeto o situación; en el caso de las puérperas, esta puede influir directamente en su decisión y comportamiento respecto a la lactancia materna; las actitudes comprenden elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y pueden presentarse de manera positiva o negativa, anticipando comportamientos constructivos o desfavorables, respectivamente (Cruz et al., 2021).

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que el 48% de los lactantes menores de seis meses son alimentados con lactancia materna a exclusividad, cifra que ha aumentado un 10% en los últimos doce años, pero aún se encuentra por debajo del objetivo del 50% fijado para el 2025; alcanzar esta meta podría evitar más de 820,000 muertes infantiles al año, no obstante, todavía existen barreras y desafíos que impiden una mayor cobertura (ONU, 2024).

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (2022) reafirma que la alimentación insuficiente en las primeras fases de la vida puede provocar daños considerables y permanentes en progresión cognitiva y evolución física, por el contrario, una nutrición apropiada genera impactos positivos y duraderos; la suspensión de la leche materna exclusiva se presenta mayormente en el primer trimestre de existencia y no se ha encontrado una identificación estadísticamente relevante entre la edad de las madres, ya que la interrupción temprana de la lactancia materna se asocia con infecciones respiratorias agudas, anemia ferropénica y mayor riesgo de hospitalización; ya que recibe únicamente leche materna (Ávalos, et al., 2022).

Desde la perspectiva del Ministerio de Salud (MINSA, 2023), la LME favorece el desarrollo óptimo del cerebro, el sistema nervioso y los órganos vitales como el hígado y los intestinos, preparándolos para la introducción de otros alimentos, y a la vez proporciona un microbiota beneficioso, esencial para fortalecer el sistema inmunológico del lactante; en este sentido, la Agencia Peruana de Noticias Andina (2024) reporta que se observó una reducción en la práctica de LME en zonas rurales del Perú, pasando del 80.7% en 2021 al 78.3% en 2023; no obstante, en áreas urbanas se evidenció un aumento de 64% en 2021 a 69.3% en 2023, (párr.2).

Diversos estudios revelan una alta predisposición positiva referente a la lactancia materna en varias regiones, por ejemplo en África, el 87% de las madres mostraron actitudes favorables; en Asia y Ecuador esta cifra alcanzó el 94.1%; en Nigeria, las mujeres con estudios superiores se convirtieron en referentes de promoción comunitaria; así mismo en Perú, el 68% de las madres Ayacuchanas mostraron actitudes positivas; en Lima, el 66.8% presentaron actitudes inadecuadas; en Lima Sur, un 56.4% tuvo una actitud indiferente y el 42.9% fue favorable; en Huancayo, el 53% manifestó estar completamente de acuerdo con la lactancia, mientras que en La Victoria (Lima), el 67.8% mostró actitudes positivas (Mamani & Vilcahuamán, 2022).

Con respecto al nivel de conocimiento sobre lactancia materna, se ha evidenciado que en Nigeria las madres con mayor nivel educativo o que ocupan cargos públicos presentan mayor comprensión sobre el tema; en Ecuador, el 46.3% de las púerperas

mostró un nivel adecuado de conocimiento; en África, el 84% tuvo conocimientos satisfactorios, mientras que, en Asia el 29% desconocía la práctica, el 11.3% ignoraba sus beneficios, y el 59.3% no contaba con información al respecto; mientras que en España, el 55% presentó conocimientos regulares, el 25% buenos y el 19.5% bajos; así mismo en el Perú, particularmente en Lima el 60% de las madres tuvieron buen conocimiento, el 66.3% regular, el 26.52% bueno y el 7.18% bajo; en La Victoria, el 73.68% presentó conocimiento entre regular y bueno, y el 26.32%, bajo; finalmente en Huancayo, el 93% comprendía adecuadamente el tema, mientras que el 7% presentaba conocimientos limitados. (Sabo et al., 2023).

En el contexto nacional, investigaciones recientes evidenciaron la necesidad de fortalecer la orientación y comprensión de las madres en periodo posparto respecto a LME. Sánchez (2023) reportó que, si bien el 70% de las madres tenía conocimientos sobre la práctica, solo el 64% se sentía suficientemente informada. En la presente investigación, el 58.9% de las puérperas manifestó una actitud favorable y el 49.5% un conocimiento alto, lo que demuestra un potencial importante para fortalecer esta práctica en la región (Sánchez, 2023).

Durante las actividades del internado clínico en el Hospital II-1 Rioja, se identificó que muchas madres mostraban limitada comprensión sobre LME, lo cual generaba actitudes variables hacia su práctica; a pesar de que existía información constante y la participación del personal, los recursos educativos disponibles no fueron suficientes, lo que afectó negativamente la seguridad y la disposición, además, factores culturales y la influencia familiar desempeñaron un papel determinante en la percepción y práctica de la lactancia materna.

De ese modo se planteó el problema de investigación:

¿Cuál es la relación que existe entre actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024?, teniendo como objetivo general: Determinar la relación que existe entre actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, en dicho hospital. Y los objetivos específicos: - Identificar la actitud sobre la lactancia materna en la dimensión cognitiva, afectiva y conductual en puérperas. - Identificar el conocimiento sobre la lactancia materna según el conocimiento básico, beneficio e importancia, en

puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín- 2024. Siendo la hipótesis: Existe una relación muy significativa entre la actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva.

El personal sanitario cumple un rol integral en la promoción de la LME , al combinar conocimientos clínicos actualizados, actitudes de apoyo y habilidades efectivas en consejería; las observaciones realizadas en el Hospital II-1 de Rioja evidencian la necesidad de fortalecer la formación continua y llevar a cabo evaluaciones periódicas de competencias, a fin de garantizar una atención de calidad; asimismo, la implementación de políticas institucionales alineadas con estándares internacionales, la integración comunitaria y el uso de herramientas de educación digital resultan fundamentales para potenciar la eficacia del personal de salud, además priorizar estas estrategias es esencial para incrementar los índices de LME y promover el bienestar materno-infantil.

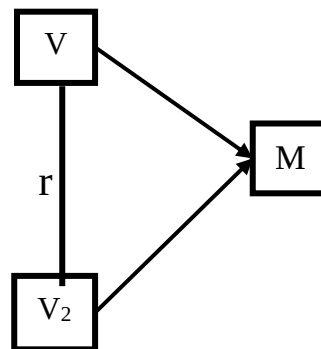
Los resultados de este estudio contribuirán a entender las dinámicas que influyen en la lactancia materna en la región y ofrecerán información valiosa para desarrollar intervenciones educativas e iniciativas de respaldo que fomentan la alimentación exclusiva con leche materna; al examinar las disparidades en la comprensión y las posturas, se anticipa un aumento en los índices de alimentación exclusiva de leche materna lo que beneficiará la salud de madres e hijos. Esta investigación aporta significativamente al bienestar de la comunidad, ya que sus hallazgos servirán como base para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias de salud pública orientadas a mejorar las condiciones en este ámbito.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Tipo de investigación:

Se adoptó un enfoque cuantitativo (realizándose la cuantificación de cifras); nivel relacional (buscó la relación entre actitudes y conocimientos); de tipo: Observacional (no se realizó ninguna intervención por el investigador); prospectivo (se recopilaron datos directamente de las puérperas); transversal (La recolección de datos se efectuó en un solo momento); Analítico (el análisis estadístico fue bivariado) (Supo, 2020).

Diagrama:



Donde:

M = Puérperas tratadas en el Hospital II-1 Rioja, San Martín

V₁ = Actitud sobre lactancia materna.

V₂ = Conocimiento sobre lactancia materna.

r = Relación.

2.2. Población de Estudio:

Estuvo constituido por 95 puérperas atendidas en el Hospital II-1 Rioja, San Martín – 2024 según detalle.

Tabla 1.

Puérperas atendidas en el Hospital II-1 Rioja desde el mes de Enero – Agosto del año 2024.

MES	PUÉRPERAS
	fi
Enero	100
Febrero	93
Marzo	104
Abril	80
Mayo	105
Junio	103
Julio	95
Agosto	83
Promedio esperado	95

Nota. Oficina de Estadística del Hospital II-1 Rioja

Criterios de inclusión:

- Puérperas que firmaron el consentimiento informado de manera voluntaria.
- Puérperas que se encontraron en buen estado de salud.
- Puérperas que tuvieron RN vivos.

Criterios de exclusión:

- Puérperas que tuvieron alguna complicación post parto.
- Puérperas que se encontraron con alguna alteración mental o con incapacidad de comprender el llenado de los cuestionarios.

Muestra

Incluyó a la totalidad de la población de estudio, que sumaron un total de 95 puérperas, considerándose de esta manera como una población muestral.

Muestreo:

No fue necesario hacer uso del muestreo ya que la muestra fue el total de la población de estudio (Supo, 2020, pp. 19 - 21).

2.3. Variables de estudio.

- V_1 = Actitud sobre LME
- V_2 = Conocimiento sobre LME

✓ Operacionalización de variables. (Anexo - 1)

2.4. Método, técnica e instrumento de recolección de datos:

a) Método

Se utilizó el método hipotético – deductivo, se contrastó la hipótesis, analizando los resultados de lo general a lo particular, (Supo, 2020).

b) Técnica de recolección de datos.

Encuesta (Supo, 2020).

c) Instrumentos de recolección de datos:

- **V_1 : Actitud sobre lactancia materna:**

Como instrumento se utilizó, un cuestionario de actitud sobre LME, constituido de 15 ítems, empleando un rango de valoración tipo Likert, de 5 respuestas desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo.

Se evaluó mediante tres categorías.

- Favorable = 55 - 75
- Medianamente favorable = 35 - 54
- Desfavorable = 15 - 34

El instrumento estuvo constituido por 3 dimensiones:

- D1= Cognitivo:
 - Favorable = 19 - 25
 - Medianamente favorable = 12 - 18
 - Desfavorable = 5 - 11
- D2 = Afectivo:
 - Favorable = 22 – 30
 - Medianamente favorable = 14 - 21
 - Desfavorable = 6 - 13
- D3 = Conductual

- Favorable = 14 - 20 puntos.
- Medianamente favorable = 9 – 13 puntos.
- Desfavorable = 4 a 8 puntos.

Validez y confiabilidad:

El instrumento fue validado en el contexto peruano por (Mamani & Vilcahuamán, 2022) con un valor 0.902; y una confiabilidad 0.794 según Alfa de Cronbach. (Anexo 3)

• **V₂ = Conocimientos sobre lactancia materna:**

Como instrumento se utilizó, un cuestionario de conocimiento sobre LME que consta de 15 ítems constituidas en escala dicotómica de distorsión, con 5 alternativas a, b, c, d, e.

Calificando todos los ítems correctamente marcados en 20 puntos y según el número de preguntas correctas se obtuvo el nivel de conocimiento.

La puntuación general se midió en las siguientes categorías:

Bajo = 0 - 11 Medio = 12 - 15 Alto = 16 - 20

Validez y Confiabilidad

El instrumento tuvo un alto grado de validez y confiabilidad según (Mamani & Vilcahuamán, 2022) con un valor de 0.889 y una confiabilidad de 0.877 mediante alfa de Cronbach. (Anexo 5)

d) Procedimiento de recolección de datos

- Se utilizó instrumentos adecuados que permitieron recabar los datos (Anexo-2 y 4)
- Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética, para ejecutar el proyecto de tesis (Anexo - 7)
- Se remitió una carta al director del Hospital II-1 Rioja, en San Martín, solicitando la autorización necesaria para realizar la recopilación de información entre las mujeres en período de posparto. (Anexo - 8)

- Se solicitó las facilidades a la enfermera(o) y/o obstetra de turno del hospital quienes brindaron facilidades en la recolección de información.
- Posteriormente, se informó a las mujeres puérperas sobre el propósito de la investigación en el servicio de Gineco - Obstetricia, a quienes se les entregó un consentimiento informado, posterior a ello el instrumento de recolección de datos para ser respondido (Anexo - 6)
- Se absolvió dudas que presentaron las madres puérperas respecto al llenado del instrumento.
- Se procedió a observar que las respuestas estén marcadas correctamente de principio a fin.
- Finalmente se realizó la codificación de datos de todas las encuestas realizadas que fueron procesadas con el programa estadístico SPSS V- 27 y Excel para la elaboración de tablas.

2.5. Análisis de datos

Los datos obtenidos fueron procesados en Microsoft Excel 2019 y SPSS versión 27. Para contrastar la hipótesis y determinar la relación entre las variables actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Chi-cuadrado (χ^2), con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.

Los resultados fueron presentados mediante tablas, permitiendo una interpretación precisa.

III. RESULTADOS

Tabla 2.

Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024.

Actitud	Conocimiento						Total	
	Bajo		Medio		Alto		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%		
Desfavorable	0	0	0	0	0	0	0	0
Medianamente favorable	4	4.2	22	23.2	13	13.7	39	41.1
Favorable	4	4.2	18	18.9	34	35.8	56	58.9
Total	8	8.4	40	42.1	47	49.5	95	100

Nota. Cuestionario de actitud y conocimiento.

$X^2 = 6.964$; gl = 2; $p_{\text{valor}} = 0.031 < 0.05$

Los datos muestran que el 35.8% de las puérperas presentaron una actitud favorable junto con un conocimiento alto en LME; solo el 23,2% actitud medianamente favorable y conocimiento medio. Además, no se registraron actitudes desfavorables, lo que indica una percepción positiva generalizada.

El análisis estadístico mediante la prueba de Chi-cuadrado arrojó un valor de $X^2 = 6.964$, con gl = 2 y $p = 0.031$, siendo este menor al nivel de significancia establecido ($\alpha = 0.05$), por lo que se aceptó la hipótesis alterna, confirmando que existe una relación significativa entre las variables de estudio.

Tabla 3.

Actitud sobre lactancia materna exclusiva según sus dimensiones en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024.

Dimensiones	Actitud						Total	
	Desfavorable		Medianamente favorable		Favorable			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Cognitivo	13	13.7	66	69.5	16	16.8	95	100
Afectivo	1	1.1	18	18.9	76	80.0	95	100
Conductual	1	1.1	16	16.8	78	82.1	95	100

Nota. Cuestionario de actitud y conocimiento.

Las dimensiones afectiva y conductual reflejan una actitud predominantemente favorable hacia LME, con 80% y 82.1% respectivamente. En cambio, la dimensión cognitiva muestra una mayoría medianamente favorable del 69.5%, y un menor porcentaje de actitud favorable del 16.8%, lo que sugiere que, aunque las puérperas tienen una disposición positiva, aún hay oportunidades de fortalecer el conocimiento teórico sobre la lactancia materna exclusiva.

Tabla 4.

Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva según sus dimensiones en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024.

Dimensiones	Conocimiento						Total	
	Bajo		Medio		Alto		fi	%
	fi	%	fi	%	fi	%		
Conocimientos básicos	13	13.7	66	69.5	16	16.8	95	100
Beneficios e importancia	1	1.1	18	18.9	76	80.0	95	100

Nota. Cuestionario de actitud y conocimiento.

La mayoría de las puérperas demostraron conocimiento alto sobre los beneficios e importancia de la LME (80%), mientras que, en la dimensión de conocimientos, predominó el conocimiento medio (69.5%). Esto indica que, aunque comprenden bien el valor de la lactancia, aún hay áreas por reforzar en cuanto a conceptos fundamentales.

IV. DISCUSIÓN

El análisis estadístico mediante la prueba de Chi-cuadrado ($p = 0.031$) evidenció una relación significativa entre el nivel de actitud y el conocimiento hacia la lactancia materna exclusiva en puérperas atendidas en el Hospital II-1 Rioja durante el año 2024. Este hallazgo indicó una relación de dependencia entre ambas variables de estudio.

En concordancia, Mamani y Vilcahuamán (2022), reportaron una relación positiva y estadísticamente significativa entre el conocimiento y la actitud materna ($r = 0,655$). De manera similar, Álvarez y Caballero (2023) obtuvieron un valor de $p = 0.000$ al analizar la asociación entre actitud y conocimiento. Por su parte, Marlo y Marlo (2022) respaldan esta correlación, al evidenciar que las puérperas con mayor nivel de conocimiento manifiestan una actitud más favorable hacia la lactancia. Asimismo, Paulino & Arévalo (2023) alcanzaron un valor de $p = 0.001$, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y confirmar la existencia de una relación significativa.

En contraste, Pineda (2023) mostró que, pese a que la mayoría de madres presentaba un buen nivel de conocimiento (79.80 %), solo una minoría manifestó actitudes favorables (24.50 %), sin evidencia de asociación estadística ($p = 0.102$). De manera similar, Benancio (2022) concluyó que el conocimiento no garantiza una actitud positiva, incluso en poblaciones con alta exposición informativa, lo que refuerza la necesidad de intervenciones más integrales, aceptando la hipótesis nula.

En cuanto a las dimensiones de la actitud hacia LME, se observa una tendencia favorable en los componentes afectivo (80%) y conductual (82.1%), donde la mayoría de las puérperas manifestó emociones positivas y disposición práctica hacia la lactancia; en cambio, la dimensión cognitiva reflejó una actitud predominantemente media (69.5%), lo que sugiere que, aunque existe apertura hacia la práctica aún hay aspectos teóricos que requieren fortalecimiento. Estos resultados reflejan una actitud mental, emocional y de comportamiento que apoya la LME, coincidiendo con investigaciones como la de Luo, et al. (2021) en Ruanda,

donde un 87% de las madres mostró una actitud positiva y el 92.3% reconoció la conexión emocional que la lactancia fomenta.

Según las dimensiones del conocimiento, los hallazgos mostraron que, en la categoría de conocimientos fundamentales, el 69.5% logró un nivel medio, mientras que, en la categoría de ventajas e importancia, el 80% alcanzó un nivel alto. Los hallazgos muestran que, aunque las puérperas comprenden bien los beneficios de la lactancia, persisten vacíos en los aspectos técnicos; en este sentido, los hallazgos son consistentes con los reportados por Mamani y Vilcahuamán (2022), quien contrastó que el 93% tiene conocimiento medio.

Los hallazgos señalan que las madres con mayor escolaridad suelen mostrar una actitud más positiva hacia LME; lo cual coincide con múltiples investigaciones previas, como las de Sabo, et al (2023) en Nigeria, Luo, et al (2021) en África, y Mamani & Vilcahuamán (2022). En cuanto a las dimensiones evaluadas, la actitud afectiva y conductual fue mayormente favorable (80% y 82.1%, respectivamente), mientras que la dimensión cognitiva mostró debilidades. Esto resalta la pertinencia de robustecer las estrategias educativas en salud, orientados a incrementar la comprensión teórica de la LME. (Anexo - 9)

De manera complementaria, los datos revelan una tendencia general favorable hacia LME, sin presencia de actitudes desfavorables en ningún grupo etario, este patrón podría reflejar el impacto positivo de las políticas de promoción y una cultura institucional que respalda esta práctica; las mujeres mayores de 30 años mostraron actitudes más favorables, posiblemente por mayor experiencia, autonomía y acceso a información en salud, en concordancia con Sabo et al. (2023), y Luo et al. (2021). En contraste, los grupos entre 15 y 24 años presentaron actitudes medianamente favorables, atribuibles a inseguridad, menor preparación o falta de redes de apoyo. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de fortalecer la educación en lactancia como estrategia comunitaria para mejorar las prácticas en salud materno-infantil. (Anexo - 10)

Otros datos revelan que, durante el puerperio inmediato y mediato, predomina un conocimiento medio y alto sobre la LME, evidenciando una preparación

informativa adecuada en la mayoría de las madres en las primeras etapas posparto. Esta tendencia coincide con lo hallado por Luo, et al. (2021), quien señala que el acompañamiento temprano del personal de salud fortalece el conocimiento técnico, favoreciendo prácticas correctas como el aseo, postura y uso del calostro. En contraste, el puerperio tardío muestra una distribución equitativa entre conocimiento bajo, medio y alto, lo cual puede reflejar que el conocimiento se hace importante con el paso del tiempo, como lo advierten De Carvalho (2019) y Sultana et al. (2022). Este hallazgo subraya la necesidad de mantener estrategias educativas hasta etapas avanzadas del posparto. La presencia de conocimiento medio y alto en las etapas inmediatas y mediatas podría explicar por qué en la tabla anterior también predominaban actitudes favorables en esos grupos etarios (Anexo - 11).

Existen otros hallazgos que también refuerzan la importancia de considerar el contexto educativo y sociocultural en las intervenciones de salud, tal como lo proponen Mamani & Vilcahuamán (2022) y De Carvalho (2019), y plantean que las acciones de promoción de LME ameritan adecuarse según la edad, nivel educativo y entorno familiar de las puérperas. Por el contrario, investigaciones como las de Carmen (2021) y Pineda (2023) no encontraron relaciones significativas entre actitud y conocimiento, lo cual podría atribuirse a diferencias contextuales, metodológicas o socioculturales.

De acuerdo con las bases teóricas, los hallazgos se sustentan en el modelo de adquisición del rol materno de Ramona Mercer, el cual plantea que la transición hacia la maternidad supone una evolución progresiva en la actitud y el conocimiento de la madre, desde la preparación emocional hasta la consolidación de su identidad como cuidadora; en este proceso, una disposición positiva y un conocimiento adecuado sobre la lactancia materna exclusiva favorecen la interacción afectiva madre-hijo, fortalecen los vínculos y consolidan la práctica de la lactancia, de modo que lo que la madre sabe influye directamente en su preparación emocional y mental para asumir el rol, mientras que su actitud refleja tanto lo que siente como lo que está dispuesta a realizar en relación con la alimentación de su hijo, siendo la decisión de ofrecer únicamente leche materna durante los primeros meses una manifestación concreta de la asunción activa de

dicho rol, en el cual el apoyo institucional y del personal de salud resulta esencial para garantizar una transición segura y positiva hacia la maternidad (Mercer, 2004).

Los hallazgos obtenidos tienen implicancias clínicas y educativas, al evidenciar la necesidad de fortalecer intervenciones centradas en la dimensión cognitiva materna. Esto implica desarrollar estrategias formativas adaptadas al nivel de conocimiento, tipo de actitud y etapa del rol materno, con el objetivo de promover una lactancia informada y consciente, y generar evidencia útil para orientar políticas públicas en salud perinatal.

V. CONCLUSIONES

1. Existe relación significativa ($p = 0.031$) entre actitud y conocimiento sobre LME en puérperas, contrastando la hipótesis alterna.
2. Se evidenció una actitud predominantemente favorable hacia la lactancia en las dimensiones afectiva y conductual, sin embargo, en la dimensión cognitiva presentó limitaciones, lo cual resalta la necesidad de consolidar la comprensión conceptual sobre el amamantamiento.
3. Aunque las puérperas comprenden los beneficios generales de la lactancia materna, presentan vacíos en la dimensión de conocimientos básicos, lo que resalta la importancia de implementar estrategias educativas orientadas a mejorar el conocimiento técnico y práctico sobre la LME.

VI. RECOMENDACIONES

Al Hospital II-1 Rioja.

Implementar consejería dirigida a madres, familias y comunidad para fortalecer la práctica de la lactancia materna exclusiva, complementada con talleres que promuevan la participación voluntaria y puedan desarrollarse en sus hogares de acuerdo a sus condiciones sociales, culturales y económicas; estas acciones, junto con visitas domiciliarias y llamadas telefónicas de seguimiento en los primeros meses, no solo refuerza el conocimiento de la madre, sino que también potencia su actitud en la dimensión cognitiva. En este nivel, la madre consolida creencias sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, razona de manera crítica acerca de sus beneficios e interpreta su significado dentro de su rol materno, lo que favorece una disposición más consciente y favorable hacia la práctica.

A la dirección de la escuela profesional de enfermería.

Fortalecer el contenido curricular acerca de lactancia materna, especialmente en la parte cognitiva. Además, fomentar prácticas preprofesionales en centros de salud y promover capacitaciones continuas en consejería materno-infantil, para mejorar la preparación del estudiante en el fomento de nutrición exclusivamente con leche materna.

A las puérperas

Participar activamente en charlas y talleres sobre lactancia materna, con énfasis en los aspectos básicos y beneficios. Asimismo, se sugiere resolver dudas con el personal de salud durante el puerperio y aplicar lo aprendido para fortalecer sus conocimientos.

A los estudiantes de la escuela profesional de enfermería

Utilizar este estudio como base para futuras investigaciones en lactancia materna exclusiva, incorporando enfoques distintos y variables complementarias, como las vivencias personales de las puérperas, factores socioculturales o el entorno familiar, con el objetivo de lograr una perspectiva más completa, que contribuya a mejorar las tácticas de fomento y respaldo a las técnicas de amamantamiento.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agencia Peruana de Noticias Andina. (2024). *Lactancia materna previene anemia en niños y cáncer de mama en miles de mujeres*. <https://andina.pe/agencia/noticia-lactancia-materna-previene-anemia-ninos-y-cancer-mama-miles-mujeres-995697.aspx>
- Ávalos, M., et al. (2022). Impacto del abandono de la lactancia materna exclusiva sobre la salud de los lactantes. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 21 (3). En: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2022000300010&lng=es&tlng=es
- Benancio, M. (2022). Conocimiento y actitud sobre la lactancia materna en madres adolescentes. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 4(1), 45–52. En <https://doi.org/10.37711/rpcs.2022.4.1.366>
- Cruz, M., Rodríguez, L., & Sánchez, P. (2021). Actitudes del personal docente universitario peruano hacia la actividad laboral en tiempos de postpandemia. *Rev. Educación y Sociedad*, 39(1), 1–15. En: <https://www.redalyc.org/journal/447/44774872003/html/>
- De Carvalho, E. (2019). Conocimientos sobre lactancia materna y relación con la prevalencia. *Rev. Da Escola de Enfermagem Da USP. Journal of school of nursing University of Sao Paulo. Vol. 53, 2019.Brasil*. En: <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018004503433>
- Freire, S. & Caluña, I. (2025). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna exclusiva: Perspectivas en gestantes y madres postparto. *Revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria.*, 45 (1). <https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/871>
- Grajales, G. (2021). *Epistemología y estados del conocimiento en la investigación educativa en México*. *Miscelánea Filosófica αρχή Revista Electrónica*, 4(11), 1–19. https://doi.org/10.31644/mfarchere_v.4;n.11/21-A01
- Hernández, Y., Martínez, D., & Pérez, L. (2023). Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en padres y madres de Santiago de Cuba. *Revista Medisan*, 27(3), 1-10. <https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/4336/html>
- Luo, J., et al. (2021). Conocimiento, actitud y práctica de la lactancia materna exclusiva entre madres que asisten al Hospital del Distrito de Masaka en

- Kigali/Ruanda: un estudio transversal. *Rev. Reseach Square*. Vol. (1). 23(01) 2023. En: <https://www.researchsquare.com/article/rs-152011/v1>
- Mamani, A., & Vilcahuaman, D. (2022). *Actitudes y conocimientos sobre lactancia materna exclusiva en puérperas de un hospital de Huancayo*. [Tesis para optar el título de Licenciada en Enfermería]. En: <https://hdl.handle.net/20.500.12848/5932>
- Marlo, J. & Marlo, L. (2022). *Conocimientos y actitudes sobre lactancia materna exclusiva en madres primíparas en el Hospital de Apoyo I Santiago Apóstol, Utcubamba*. [Tesis para obtener el título profesional de médico]. Accesado en: <https://hdl.handle.net/20.500.12802/14561>
- Mercer, R. (2004). Becoming a mother: Research on maternal role attainment and transition. Springer Publishing Company. *Revista de Investigación en Enfermería*. Volumen 36, Número 3 págs. 226-232. En: <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004.04042.x>
- MINSA. (2023). *Porcentaje de menores de seis meses con lactancia materna se incrementó a lo largo del 2023*. En: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/960637-porcentaje-de-menores-de-seis-meses-con-lactancia-materna-se-incremento-a-lo-largo-del-2023?utm_source=chatgpt.com
- OMS (2023). *Lactancia materna exclusiva para un óptimo crecimiento, desarrollo y salud de los lactantes*. En: <https://www.who.int/tools/elena/interventions/exclusive-breastfeeding>
- ONU. (2024). La lactancia materna podría salvar la vida de más de 820.000 niños al año. *Rev. Noticias ONU – audioteca*. En: <https://news.un.org/es/story/2024/08/1531681>
- OPS. (2022). *Lactancia materna y alimentación complementaria*. Paho.org. con acceso en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria?utm>
- Paulino, J. C., & Arévalo, R. (2023). Conocimientos y prácticas sobre la lactancia materna exclusiva en madres de menores de 6 meses atendidos en el Centro de Salud Collique III Zona, Comas 2023. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 1–15. En: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6357

- Pineda, J. (2023). Conocimiento sobre lactancia materna y actitud de las madres de niños atendidos en un puesto de salud. *Rev. Investigación e Innovación*, 3(1), 62–67. En: <https://doi.org/10.33326/27905543.2023.1.1754>
- Sabo, A., et al. (2023). Conocimientos, actitudes y prácticas de la lactancia materna exclusiva entre madres en edad fértil. *Revista frente salud Pública*. Vol. 11 – 2023. En: doi: 10.3389/fpubh.2023.1277813
- Sultana, M., et al. (2022). Conocimientos, actitudes y predictores de la práctica de la lactancia materna exclusiva entre madres lactantes en Noakhali, Bangladesh. *Rev. Heliyon*. Vol. 8, número 10 - 2022. En: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11069>
- Supo, J. (2020). *Seminarios de investigación científica para la investigación de la ciencia en salud*. Edic. 3°. Edit. Moderna del Perú. Lima. En: <https://pdfcookie.com/documents/libro-seminario-investigacion-cientifica-dr-supo-trad-mlxz30mrok27>

ANEXOS

Anexo - 1

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable 01	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Categorías		Escala
						Dimensiones	Variable	
V ₁ = Actitud sobre lactancia materna	Disposición mental y emocional de una persona hacia los cuidados de algo o alguien con tendencia innata o adquirida a sentir y actuar de manera determinada, logrando determinados objetivos.	Es la disposición de la madre puerpera para mejorar la lactancia materna de su recién nacido. Será medido con el cuestionario de actitudes en puerperas sobre lactancia Materna exclusiva	Cognitivo	Enojo, deformación y dolor de pezones, prevención de enfermedades, suspensión por diarrea.	5 ítems 1,2,3,4,5	Favorable: 19 – 25 pts. Medianamente Favorable: 12 – 18 pts. Desfavorable: 5 – 11 pts.	Favorable 55 – 75 pts.	Variable = se midió a través de la escala ordinal. Los ítems tienen respuestas en la escala Likert: 5= Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Ni en acuerdo ni en desacuerdo 2= En desacuerdo 1= Totalmente en desacuerdo
			Afectivo	Hablar al bebé, satisfecha, lazo de amor, alegre, desagrado, incomodidad	6 ítems 6,7,8,9,10,11	Favorable: 22 – 30 pts. Medianamente Favorable: 14 – 21 pts. Desfavorable: 6- 13 pts.	Medianamente favorable 35 – 54 pts.	
			Conductual	Continuidad de lactancia, Suspende, Agarre del pezón adecuado, impedimento por lactancia.	4 ítems 12,13,14, 15	Favorable: 14 – 20 pts. Medianamente Favorable: 9 – 13 pts. Desfavorable: 4 – 8 pts.	Desfavorable 15 – 34 pts.	

Variable 2	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems	Categorías		Escala
						Dimensiones	Variable	
V ₂ = Conocimientos Sobre lactancia materna	Es un resultado de comprensión que se obtiene durante un proceso de manera progresiva, teniendo un sujeto capaz de aprender a través de las experiencias	Es la información anticipada que adquirió la madre sobre la lactancia materna exclusiva. Fue medido con el cuestionario de conocimientos de puérperas sobre lactancia materna exclusiva.	Conocimientos básicos	Lactancia materna, edad, etapas, lavado de manos, mejor alimento, inicio, tiempo de amamantamiento,	7 ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Alto = 16 – 20 Medio = 12 – 15 Bajo = 0- 11	Alto = 16 – 20 Medio = 12 – 15 Bajo = 0- 11	Variable = Se midió mediante la escala ordinal. Los ítems tienen respuestas en la escala dicotómica de distorsión: Con alternativas: a, b, c, d, e
			Beneficios e importancia	Calostro, alimento fuera de casa, no brindar lactancia, beneficio, posición adecuada, succión.	8 ítems 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	Alto = 16 – 20 Medio = 12 – 15 Bajo = 0- 11		

Anexo – 2

Instrumento de recolección de datos de actitud

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS



ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA CUESTIONARIO DE ACTITUD EN PUÉRPERAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (Mamani & Vilcahuamán, 2022)

I. INTRODUCCIÓN:

Estimada madre de familia el presente instrumento se aplicará con el objetivo de Determinar la relación que existe entre Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín- 2024. Por lo que a continuación se presentan una serie de preguntas a fin de que pueda responder con sinceridad, el mismo que servirá exclusivamente para fines de estudio.

II. Indicaciones:

Marque con un aspa (X) o subraye la alternativa que usted considere correcta.

III. Datos Generales:

Edad: 15 a 19 años (). 20 a 24 años(). 25 a 29 años(). 30 a 35 años() 36 años a más ()

Sexo: M = (). F = () Grado de instrucción:

Ocupación: Número de Hijos:

Estado civil: Soltera (). Casada: () Divorciada() Viuda() conviviente()

IV. Actitudes de las puérperas sobre lactancia materna exclusiva.

Marque la respuesta con total sinceridad donde:

5= Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

2= En desacuerdo 1= Totalmente en desacuerdo

Nº	ITEMS	VALORES				
		5	4	3	2	1
	DIMENSIÓN COGNITIVO					
1	Si la madre está enojada, no debe dar de lactar					
2	Dar de lactar a demanda, deforma las mamas de la madre					
3	La leche materna protege de infecciones al bebe					
4	Se debe de suspender la lactancia materna cuando el bebé presenta diarrea					
5	Las mujeres que tienen mamas pequeñas, no tienen leche					
	DIMENSIÓN AFECTIVO					
6	Habla al bebe cuando da lactar					
7	Se siente satisfecha cuando da de lactar a su bebe					
8	Hay fortalecimiento de lazo de amor cuando da de lactar					
9	Siente alegría cuando ve feliz a su bebe después de dar de lactar					
10	Me desagrada dar de lactar porque me produce dolor en las mamas					
11	Me incomoda mucho dar de lactar a cada rato a mi bebe					
	DIMENSIÓN CONDUCTUAL					
12	Si tu bebe se enferma debes continuar dándole tu pecho					
13	Si usted sufre de alguna enfermedad debes de seguir dándole tu pecho a tu bebe					
14	Vigilo la boca de mi bebe que debe de estar abierta agarrando todo el pezón					
15	Trabajar es un impedimento para dar de lactar a mi bebé					

Anexo - 3

Cuestionario de Actitud sobre lactancia Materna Exclusiva validado por Mamani & Vilcahuaman, (2022).

VALIDEZ DE CONSTRUCTO DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES EN PUÉRPERAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		.902
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3690.452
	gl	351
	Sig.	.000

MATRIZ DE COMPONENTE ROTADO ^a			
	Componente		
	1	2	3
1. Si la madre está enojada. No debe dar de lactar	0.798		
2. Dar de lactar a demanda deforma las mamas de la madre	0.785		
3. La leche materna protege de infecciones al bebe	0.750		
4. Se debe de suspender la lactancia materna cuando él bebe presenta diarrea	0.736		
5. Las mujeres que tienen mamas pequeñas, no tienen leche	0.725		
6. Habla al bebe cuando da de lactar	0.722		
7. Se siente satisfecha cuando da de lactar a su bebe		0.826	
8. Hay fortalecimiento de lazo de amor cuando da de lactar		0.763	
9. Siente alegría cuando ve feliz a su bebe después de dar de lactar		0.761	
10. Me desagrada dar de lactar porque me produce dolor en las mamas		0.588	
11. Me incomoda mucho dar de lactar a cada rato a mi bebe		0.506	
12. Si tu bebe se enferma debes continuar dándole tu pecho			0.718
13. Si usted sufre de alguna enfermedad debes de seguir dándole tu pecho a tu bebe			0.715
14. Vigilo la boca de mi bebe que debe de estar abierta agarrando todo el pezón			0.636
15. Trabajar es un impedimento para dar de lactar a mi bebe			0.624
Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con Normalización Kaiser.			

Fuente: Datos de la prueba piloto en 15 puérperas atendidas en "HRDMI EL CARMEN 2022"

**CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES EN PUÉRPERAS SOBRE
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA**

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.794	15

Estadística de total de elemento

	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
1.-Si la madre está enojada. No debe dar de lactar	0.780
2.-Dar de lactar a demanda deforma las mamas de la madre	0.796
3.-La leche materna protege de infecciones al bebe	0.782
4.-Se debe de suspender la lactancia materna cuando el bebe presenta diarrea	0.802
5.-Las mujeres que tienen mamas pequeñas, no tienen leche	0.796
6.-Habla al bebe cuando le da de lactar	0.744
7.-Se siente satisfecha cuando da de lactar a su bebe	0.742
8.-Hay fortalecimiento de lazo de amor cuando da de lactar	0.765
9.-Siente alegría cuando ve feliz a su bebe después de dar de lactar	0.755
10.-Me desagrada dar de lactar porque me produce dolor en las mamas	0.794
11.-Me incomoda mucho dar de lactar a cada rato a mi bebe	0.815
12.-Si tu bebe se enferma debes continuar dándole tu pecho	0.747
13.-Si usted sufre de alguna enfermedad debes de seguir dándole tu pecho a tu bebe	0.803
14.-Vigilo la boca de mi bebe que debe de estar abierta agarrando todo el pezón	0.761
15.-Trabajar es un impedimento para dar de lactar a mi bebe	0.815

Fuente: Datos de la prueba piloto en 15 puérperas atendidas en "HRDMI EL CARMEN 2022"

VALIDEZ POR JUICIO DE EXPERTOS

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO:

CUESTIONARIO DE ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN PUÉRPERAS

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los ítems están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de ítems que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros ítems		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dra. Luz Maribel Díaz Galarza

Título o grado académico: Doctora en Educación

Luz Maribel Díaz Galarza
Dra. Luz Maribel Díaz Galarza
CEP: 025782

Dra. Luz Maribel Díaz Galarza
DNI: 20721828
CEP: 25782

**FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS**

TÍTULO:

**CUESTIONARIO DE ACTITUDES SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA
EN PUÉRPERAS**

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los ítems están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de ítems que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros ítems		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dr. Ramos Morales, Luis Edwin

Título o grado académico: Médico Cirujano

(Firma)
Dr. Luis E. Ramos Morales
DIRECTOR GENERAL
C.R.E. 51876

Mg.

DNI: 41214764
CEP: 61876

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS

TÍTULO:

..... CUESTIONARIO DE ACTITUDES SOBRE LA INICIATIVA MATERNA
..... EXCLUSIVA EN PUERPERAS
.....

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los ítems están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de ítems que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros ítems		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dr. JAVIER A SANTOS GAUJAN

Título o grado académico: Mg. EN REHABILITACIÓN

Javier A. Santos Gaujan
MEDICO PERUANO

Mg.

DNI: 06754735
CEP: 20370

Anexo - 4

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO ROPDRIGUEZ DE MENDOZA DE



AMAZONAS:

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD:

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DE PUÉRPERAS SOBRE

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

(Mamani & Vilcahuaman,2022)

I. INTRODUCCIÓN:

Estimada madre de familia el presente instrumento se aplicará con el objetivo de Determinar la relación que existe entre Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín- 2024. Por lo que a continuación se presentan una serie de preguntas a fin de que pueda responder con sinceridad, el mismo que servirá exclusivamente para fines de estudio.

II. Datos Generales:

Edad: 15 a 19 años (). 20 a 24 años(). 25 a 29 años(). 30 a 35 años() 36 años a más ()

Sexo: M = (). F = () Grado de instrucción:

Ocupación: Número de Hijos:

Estado civil: Soltera (). Casada: () Divorciada() Viuda() conviviente()

III. Indicaciones:

Marque con un aspa (X) o subraye la alternativa que usted considere correcta.

1. ¿Qué es para usted la leche materna exclusiva? Marca la correcta

- a. El mejor alimento para el recién nacido hasta los seis meses
- b. Un buen alimento hasta los 2 años
- c. Alimento con vitaminas, pero sin macro ni micronutrientes
- d. La comida de los bebés
- e. Ninguna de las anteriores

2. ¿Hasta qué edad es lo recomendable dar la lactancia materna exclusiva?

- a. Menos de un mes
- b. Hasta los (6) meses Lactancia Materna Exclusiva

- c. De seis (6) meses a unos 2 años
- d. De dos años (2) hasta los 5 años
- e. Dos años

3. ¿Cuáles son las etapas de la Leche Materna? Marca la correcta

- a. Calostro, Leche de transición y Leche madura
- b. Leche de transición y calostro
- c. Solo leche madura
- d. Solo la b
- e. Ninguna de las respuestas

4. Antes de dar de lactar al bebe el aseo de manos debe de ser:

- a. Lavarse las manos con agua y jabón
- b. Lavarse las manos solo con agua
- c. Lavarse las manos con alcohol
- d. No lavarse las manos
- e. Solo pasarse jabón liquido

5.- ¿Cuál es el mejor alimento para el recién nacido sano o enfermo?

- a. Leche en polvo para bebe
- b. Leche entera
- c. Leche materna
- d. a y b
- e. Leche materna y leche en polvo

6.- El calostro es:

- a. El peor alimento que sale del pecho con menos defensas y nutrientes
- b. El nombre que recibe la bajada de la leche con menos importancia
- c. El alimento perfecto y primordial con suma importancia para el recién nacido durante la primera hora de vida
- d. Ninguna de las anteriores
- e. Todas las anteriores

7.-¿Cuándo se debe iniciar la lactancia materna?

- a. A las 4 horas de nacido del bebe
- b. Inmediatamente después del parto
- c. Cuando él bebe llora de hambre por primera vez
- d. Ninguna de las anteriores
- e. Todas las anteriores

8.- ¿Cada que tiempo debe de mamar él bebe?

- a) Cada 1 horas
- b) Cada 2 horas
- c) Cada 4 horas

- d. A libre demanda
- e. Cada vez que él bebe lllore

9.- Si Ud. Trabaja fuera de su casa ¿Como usted cree que debe de alimentar a su bebé?

- a. Le daría leche materna mientras este con mi bebe y leche artificial cuandome iría al trabajo.
- b. Solo le daría leche en polvo.
- c. Dejaría a mi bebe con mi mama.
- d. Preferible tendría que darle leche materna extraída en casa o en el trabajo.
- e. Me la llevaría al trabajo.

10.- ¿Que madres no deben de dar de lactar a su bebe?

- a. Madres que tienen cáncer.
- b. Madres que tiene VIH/ SIDA
- c. Madres que tiene tos
- d. Madres que tiene el pezón invertido
- e. Madres que tienen varios hijos

11.- ¿El beneficio de la lactancia materna para él bebe es?

- a. Protege al niño solo contra algunas enfermedades
- b. Protección contra anticuerpos que los protegen de infecciones
- c. Protege solo contra enfermedades respiratorias
- d. Alimenta al bebe solo 6 meses
- e. Ninguna de las anteriores

12.- ¿El beneficio de la lactancia materna para la madre es?

- a. Recuperación posparto
- b. Menores niveles de ansiedad
- c. Ayuda establecer vínculo entre tú y tu bebe
- d. La lactancia materna permite ahorrar tu dinero
- e. Todas las anteriores

13.- ¿La posición de su bebe debe de ser?

- a. Pegado al seno, coge areola, brazo alrededor de la cintura de la madre.
- b. Pegado al seno, coge pezón, brazo alrededor de la cintura de la madre.
- c. Pegado al seno, coge pezón y gran parte de la areola, brazo alrededor de la cintura de la madre.
- d. Pegado al seno. Coge pezón y areola, brazo alrededor de la cintura de la madre.
- e. Ninguna de las anteriores.

14.- La succión de la leche materna debe ser:

- a. Mamadas muy rápidas.
- b. Mamadas cada 5 minutos.
- c. Mamadas superficiales.
- d. Mientras él bebe duerma.
- e. Mamadas lentas profundas y con pausas.

15.- Cuando hay grietas en el pezón. Usted debe de:

- a. Mantener una misma posición.
- b. Suspendir la lactancia.
- c. Cambiar de posición para que agarre otra parte de la areola.
- d. No se.
- e. Nunca cambiar de posición.

Anexo – 5

Cuestionario de Conocimiento sobre lactancia Materna Exclusiva validado por Mamani & Vilcahuaman, (2022).

VALIDEZ DE CONSTRUCTO DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS EN PUÉRPERAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

Prueba de KMO y Bartlett		
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo		.889
Prueba de esfericidad de Bartlett	Aprox. Chi-cuadrado	3840.526
	gl	325
	Sig.	.001

MATRIZ DE COMPONENTE ROTADO ^a			
	Componente		
	1	2	3
1. ¿Qué es para usted la leche materna exclusiva?	0.721		
2. ¿Hasta qué edad es lo recomendable dar la lactancia materna exclusiva?	0.806		
3. ¿Cuáles son las etapas de la Leche Materna?	0.894		
4. Antes de dar de lactar al bebe el aseo de manos debe de ser:	0.819		
5. ¿Cuál es el mejor alimento para el recién nacido sano o enfermo?	0.838		
6. El calostro es	0.964		
7. ¿Cuándo se debe iniciar la lactancia materna?		0.791	
8. ¿Cada que tiempo debe de mamar el bebe?		0.522	
9. Si Ud. Trabaja fuera de su casa ¿Como usted cree que debe de alimentar a su bebe?		0.928	
10. ¿Qué madres no deben de dar de lactar a su bebe?		0.810	
11. ¿El beneficio de la lactancia materna para el bebe es?			0.708
12. ¿El beneficio de la lactancia materna para la madre es?			0.635
13. ¿La posición de su bebe debe de ser?			0.706
14. La succión de la leche materna debe ser			0.814
15. Cuando hay grietas en el pezón. Usted debe de			0.650
Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.			

Fuente: Datos de la prueba piloto en 15 puérperas atendidas en "HRDMI EL CARMEN 2022"

**CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS EN PUÉRPERAS
SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA**

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
.817	15

Estadística de total de elemento

	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
1. ¿Qué es para usted la leche materna exclusiva? Marca la correcta	0.799
2. ¿Hasta qué edad es lo recomendable dar la lactancia materna exclusiva?	0.799
3. ¿Cuáles son las etapas de la Leche Materna? Marca la correcta	0.814
4. Antes de dar de lactar al bebé el aseo de manos debe de ser:	0.782
5.- ¿Cuál es el mejor alimento para el recién nacido sano o enfermo?	0.799
6.- El calostro es:	0.799
7.- ¿Cuándo se debe iniciar la lactancia materna?	0.794
8.- ¿Cada que tiempo debe de mamar el bebé?	0.799
9.- Si Ud. Trabaja fuera de su casa ¿Como usted cree que debe de alimentar a su bebé?	0.808
10.- ¿Que madres no deben de dar de lactar a su bebé?	0.814
11.- ¿El beneficio de la lactancia materna para el niño es?	0.809
12.- ¿El beneficio de la lactancia materna para la madre es?	0.791
13.- ¿La posición de su bebé debe de ser?	0.851
14.- La succión de la leche materna debe ser:	0.797
15.- Cuando hay grietas en el pezón. Usted debe de:	0.837

Fuente: Datos de la prueba piloto en 15 puérperas atendidas en "HRDMI EL CARMEN 2022"

**FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE
DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS**

TÍTULO:
CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE PUÉRPERAS

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los ítems están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de ítems que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros ítems		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dra. Luz Maribel Díaz Galarza

Título o grado académico: Doctora en Educación

Luz Maribel Díaz Galarza
Dra. Luz Maribel Díaz Galarza
CEP: 025782

Dra. Luz Maribel Díaz Galarza
DNI: 20721828
CEP: 25782

**FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS**

TÍTULO:

..... CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MATERIA
..... EXCLUSIVA EN PUERTO RICO

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los items están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de items que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros items		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dr. JAVIER A SANTOS GAUIN

Título o grado académico: Mg. EN REHABILITACIÓN

Javier A. Santos Gauin
MEDICO PERUANO

Mg.

DNI: 06754735
CEP: 20370

**FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
DATOS SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS**

TÍTULO:

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE PUÉRPERAS

N°	PREGUNTA	JURADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	El instrumento responde al planteamiento del problema	X		
2	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos generales	X		
3	El instrumento persigue los fines los fines de los objetivos específicos	X		
4	Las dimensiones que se han tomado en cuenta son adecuadas para la realización del instrumento	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de las variables	X		
6	La escala utilizada es correcta	X		
7	Los reactivos siguen un orden lógico	X		
8	Los ítems están redactados en forma clara y precisa	X		
9	El número de ítems que cubre cada dimensión es el correcto	X		
10	Se deben considerar otros ítems		X	

Sugerencias: _____

Datos del validador: Dr. Ramos Morales, Luis Edwin

Título o grado académico: Médico Cirujano

Mg.


Dr. Luis E. Ramos Morales
DIRECTOR GENERAL
C.M.P. 01870

DNI:
CEP:

Anexo - 6

Consentimiento informado

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada madre de Familia

Soy Interna en Enfermería y se está realizando el proyecto de investigación el cual tiene como objetivo: Determinar la relación existente entre Actitud y conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024. Por ello solicito su consentimiento para su participación de manera voluntaria durante el proceso de la investigación. La información que se recoja de este estudio será confidencial y será utilizada solo para fines de investigación.

Para las preguntas o dudas sobre este estudio puede comunicarse al número 917589138.

Por ello, yo acepto mi participación de forma voluntaria del presente estudio.

Y a la vez estoy informado (a) del proceso de la participación en el estudio que se esta llevando a cabo por la Int. Enf. Raquel Vasquez Regalado.

Firma de la persona encuestada

DNI:

Firma de la Investigadora

DNI:

Anexo - 7

Constancia de aprobación de proyecto de tesis del comité institucional de ética de la investigación científica – UNTRM

CONSTANCIA

CIEI-Nº 00158.

El que suscribe, presidente del comité institucional de ética en investigación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, deja constancia que el proyecto de investigación titulado:

“Actitud y conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en puérperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín - 2024.”

Ha sido evaluado por el comité, habiéndose encontrado que el proyecto está elaborado de acuerdo a los estándares propuestos para cumplir con los lineamientos éticos en la investigación y que se ejecutará bajo el patrocinio de (la/el): Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM); bajo la responsabilidad de **Raquel Vásquez Regalado**, como Investigador principal.

Chachapoyas, 27 de marzo de 2025.

C/c
ciei


Firmado digitalmente por:
TORRES ARMAS Blas
Alberto FAU 20470303668 soft
Activo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/03/2025 22:07:19-0500

Anexo - 8

Solicitud y respuesta por parte de la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación del Hospital II- Rioja para aprobación del proyecto.



OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO

HOSPITAL II-1 RIOJA

"Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Somos
Gente

Rioja, 15 de noviembre del 2024

CARTA N° 022-2024-HOSPITAL II-1 RIOJA /UCADI

Sra.

RAQUEL VASQUEZ REGALADO

Bachiller de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN.

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo, informarle que, mediante la solicitud, se autoriza recolección de datos y aplicar proyecto de investigación en el Hospital II - 1 Rioja, titulada "Actitud y Conocimiento sobre Lactancia Materna Exclusiva en puerperas, Hospital II-1 Rioja, San Martín-2024". Para obtener el título de Licenciado en enfermería

Expongo, que en atención directa a la Ley N° 30220 (Ley Universitaria) en cuyo capítulo VI, artículo 51 se menciona que: "Las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado, para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país". Y en consideración indirecta a las leyes N° 30309 (Ley que promueve la investigación científica) y N° 28303 (Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica), la entidad a la cual representó, en coordinación con el comité de investigación científica (CIC) y comité de ética en investigación (CEI) se reconoce la trascendencia de la investigación y al estar en conformidad a la normativa mencionada y lineamientos que rigen nuestra institución se dan por concedidos los permisos necesarios para realiza el recojo de información y ejecución del trabajo de investigación.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle muestras de especial consideración y estima.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL SALUD RIOJA
HOSPITAL II-1 RIOJA
Ing. Sst. Lusgarda Wian Puelles Chuquimanta
POTE. COMITÉ DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL SALUD RIOJA
HOSPITAL II-1 RIOJA
Ing. Comp. Sst. Johan Alexander Zaguceta Doza
DIP- 158521
POTE. COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN
UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL SALUD RIOJA
HOSPITAL II-1 RIOJA
LIC. EMP. AP. JUDITH TUESTA
RESP. OFICINA DE CAPACITACIÓN
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE CAPACITACIÓN Y APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL
II-1 RIOJA
Jr. Jirón Venecia C-6, Rioja 22826

Hospital II-1
Rioja

Anexo - 9

Tabla 5

Actitud sobre lactancia materna exclusiva según grado de instrucción en puérperas del Hospital II-1 Rioja, San Martín, 2024.

Grado de instrucción	Actitud						Total	
	Desfavorable		Medianamente favorable		Favorable			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Sin estudios	0	0	1	50	1	50	2	100
Primaria incompleta	0	0	0	0	1	100	1	100
Primaria completa	0	0	9	45	11	55	20	100
Secundaria incompleta	0	0	4	26.7	11	73.3	15	100
Secundaria completa	0	0	18	47.4	20	52.6	38	100
Superior	0	0	7	36.8	12	63.2	19	100
Total	0	0	39	41.1	56	58.9	95	100

Nota. Cuestionario de actitud sobre lactancia materna exclusiva.

Anexo - 10

Tabla 6

Actitud sobre lactancia materna exclusiva según grupo etario en puérperas del Hospital II-1 Rioja, San Martín, 2024.

Edad	Actitud						Total	
	Desfavorable		Medianamente favorable		Favorable			
			fi	%			fi	%
	15 - 19 años	0	0	6	50	6	50	12
20 - 24 años	0	0	14	56	11	44	25	100
25 -29 años	0	0	8	44.4	10	55.6	18	100
30 - 35 años	0	0	3	25	9	75	12	100
36 a más	0	0	39	41.1	56	58.9	95	100
Total	0	0	70	43.2	92	56.8	162	100

Nota. Cuestionario de actitud sobre lactancia materna exclusiva.

Anexo - 11

Tabla 7

Conocimiento sobre lactancia materna exclusiva según etapas del puerperio, en púerperas del Hospital II- Rioja, San Martín, 2024.

Puerperio	Conocimiento						Total	
	Bajo		Medio		Alto			
	fi	%	fi	%	fi	%	fi	%
Inmediato	3	7.9	17	44.7	18	47.4	38	100
Mediato	4	7.5	21	39.6	28	52.8	53	100
Tardío	1	25	2	50	1	25	4	100
Total	8	8.4	40	42.1	47	49.5	95	100

Nota. Cuestionario de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva.

Anexo - 12

Galería fotográfica de la recolección de datos.

